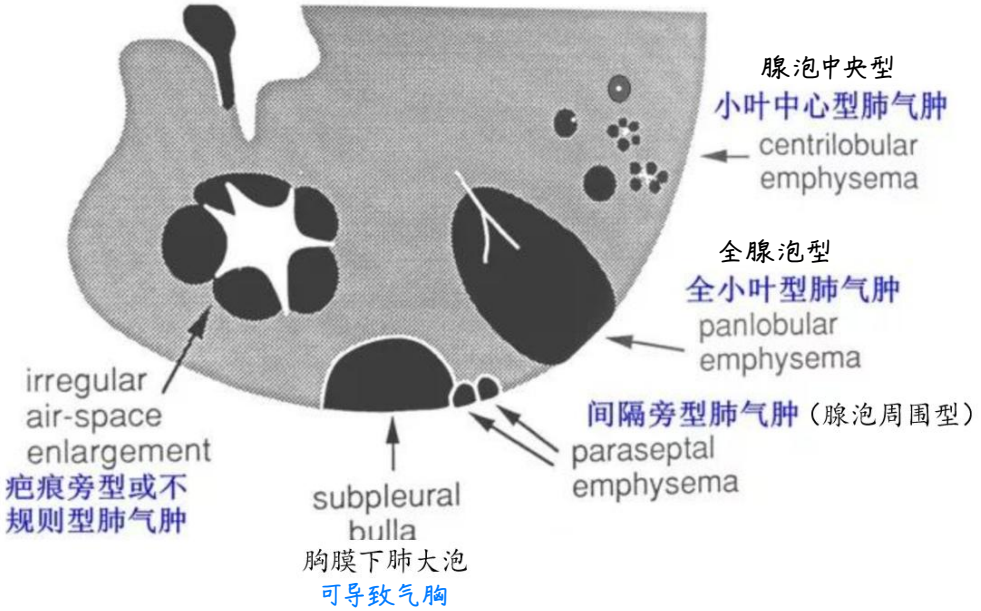
小结肺气肿的分类（小叶中央、小叶周围、全小叶型是旧称）



四、慢性肺源性心脏病/慢性肺心病 肺部疾病基本上可以导致肺心病

慢支 —（细支气管及其周围组织的慢性炎症）→ 肺气肿 —（不是肺小A；毛细血管数量减少→肺循环阻力增加→肺动脉高压（关键））→ 肺心病

右心室后负荷↑-右心室心肌肥厚代偿一久之失代偿出现右心衰

1.病因

慢支炎一阻塞性肺气肿一发展为不可逆的气流受限即COPD

慢性肺疾病	**慢支炎并发阻塞性肺气肿（最常见）**、支扩、支气管哮喘、硅肺（肺组织弥漫纤维化（肉芽组织→纤维瘢痕））、慢性纤维空洞型肺结核、特发性肺间质纤维化等
胸廓病变	严重**脊柱侧凸**等致胸廓活动受限
肺血管病变	**虫卵**等致广泛或反复的肺小动脉栓塞 肺动脉压力↑

2.病理变化

（1）肺

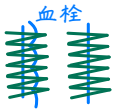
①原有肺疾病的表现

感性认识:长平滑肌,平滑肌增多导致肺血管痉挛收缩 机化✗ 肉芽组织

②**缺氧致肺血管痉挛和重构**（**肺小动脉**为主）：无肌型细动脉**肌化**、肌型小动脉**中膜增厚**、内膜下出现纵行平滑肌束、小动脉炎、小动脉**胶原纤维增生**、腔内血栓形成和机化（坏死组织、血栓、异物等被肉芽组织取代）、**肺泡间隔毛细血管数量减少**

肺小A对缺氧最敏感

受肺大疱压迫



内在逻辑：肺循环阻力增加，因此不会出现血管纤维素样坏死（胶原纤维坏死）

整个过程都不会出现纤维素样坏死如果胶原纤维坏死了,血管阻力就下降了,所以一定是胶原纤维增生